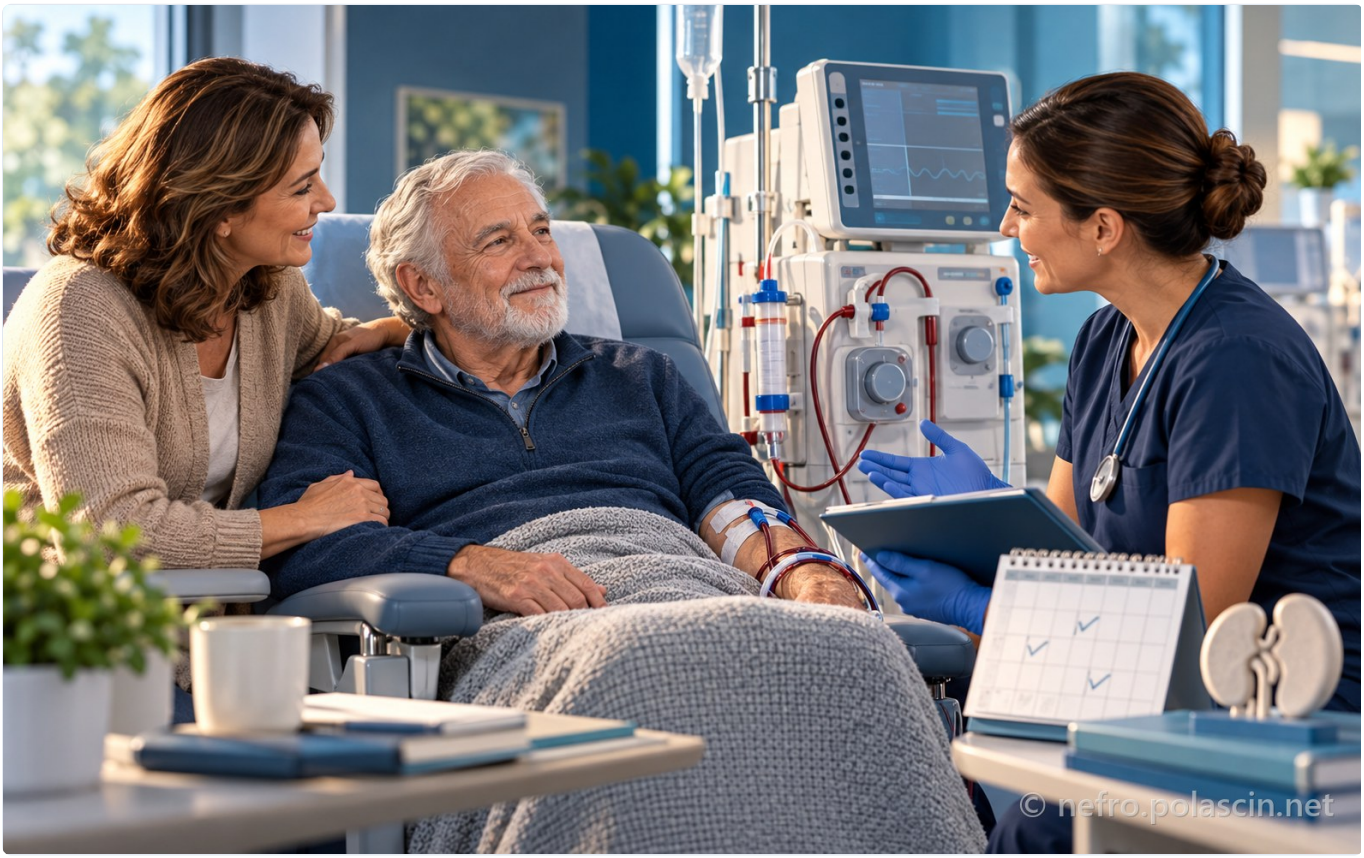
Ako žiť s hemodialýzou: rady starších pacientov a ich partnerov starostlivosti

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.09.2026



Úspešné zvládanie hemodialýzy nie je iba technický výkon. Vyžaduje pripraveného pacienta, podporovaného partnera starostlivosti a tím, ktorý ich učí spolupracovať.

Čo by starší ľudia v prvom roku hemodialýzy poradili tým, ktorí ju práve začínajú? Kvalitatívna štúdia v American Journal of Kidney Diseases prináša sedem tém, ktoré sa netýkajú iba medicínskych parametrov. Do popredia stavia pripravenosť, vzťah medzi pacientom a blízkym človekom, praktické vedomosti, sebaopateru a organizáciu každodenného života.

Začatie hemodialýzy mení rytmus týždňa, rodinné úlohy, dopravu, stravovanie, lieky aj plánovanie bežných povinností. Starší pacient pritom môže súčasne žiť s krehkosťou, poruchou mobility, zmyslovými alebo kognitívnymi obmedzeniami a viacerými chronickými ochoreniami. Časť práce preto často preberá blízky človek.

Autori skúmanej práce používajú pojem **partner starostlivosti** (*care partner*). Môže ním byť manžel, partner, príbuzný alebo priateľ, ktorý pomáha s organizáciou liečby, dopravou, komunikáciou a každodennými rozhodnutiami. Tento pojem lepšie vystihuje spoluprácu než automatické označenie „opatrovateľ“, pretože nie každý takýto človek poskytuje formálnu opatrovateľskú službu.

Čo presne skúmala štúdia

DePasquale a spoluautori uskutočnili deskriptívnu kvalitatívnu štúdiu v zdravotníckom systéme Duke Health. Zaradili dospelých vo veku najmenej 65 rokov, ktorí dostávali strediskovú hemodialýzu najviac jeden rok, a ich primárnych partnerov starostlivosti. Každý účastník absolvoval pološtruktúrovaný rozhovor a dotazníkové zisťovanie. Prepisy rozhovorov boli spracované kombinovanou deduktívno-induktívnou tematickou analýzou.

Rozhovory dokončilo **33 pacientov a 36 partnerov starostlivosti**. Výsledkom nie je skúška účinnosti konkrétneho edukačného programu ani dôkaz, že jedna rada zlepší prežívanie či zníži počet hospitalizácií. Ide o systematicky analyzovanú skúsenosť ľudí, ktorí prešli prvým rokom strediskovej hemodialýzy.

Sedem tém, ktoré účastníci považovali za podstatné

Rady určené pacientom

1. **Postoj pacienta ovplyvňuje, ako prežíva liečbu.** Účastníci zdôrazňovali prijatie novej reality, aktívnu účasť a snahu zachovať pozitívny, ale realistický prístup.
2. **Starostlivosť o celkové zdravie pomáha zvládať dialyzačné sedenia.** Nejde o prísľub bezproblémovej liečby, ale o dôraz na sebaopateru, primeranú aktivitu, lieky a režim dohodnutý s dialyzačným tímom.

Rady určené partnerom starostlivosti

3. **Pripravte sa na významný záväzok.** Pomoc pri hemodialýze prináša nové úlohy, časové nároky a dôsledky pre vlastný život partnera starostlivosti.
4. **Dlhodobé odsúvanie vlastných potrieb je kontraproduktívne.** Sebaopatera nie je sebeckosť. Vyčerpaný blízky človek má menšiu kapacitu poskytovať bezpečnú a udržateľnú podporu.

Rady spoločné pre pacienta a partnera starostlivosti

5. **Budujte pevný, spolupracujúci a podporujúci vzťah.** Dvojica nemá fungovať ako pasívny pacient a neobmedzene dostupný pomocník, ale ako tím s dohodnutými úlohami a priestorom na otvorenú komunikáciu.
6. **Získavajte informácie pred začatím dialýzy aj po ňom.** Potreby sa menia. To, čomu pacient nerozumel pred prvým sedením, môže byť zrozumiteľné a prakticky dôležité o niekoľko týždňov neskôr.
7. **Plánujte dopredu a organizujte každodenný život.** Harmonogram dialýzy treba prepojiť s dopravou, liekmi, jedlom, odpočinkom, kontrolami a rodinnými povinnosťami.

Čo z výsledkov možno preniesť do dialyzačnej praxe

Nasledujúce kroky sú **klinickou interpretáciou** výsledkov, nie intervenciami priamo testovanými v tejto kvalitatívnej štúdii.

1. Edukáciu rozdeliť v čase

Jednorazové poučenie pred prvou dialýzou nestačí. Pacient a partner starostlivosti potrebujú základnú orientáciu pred začatím liečby, praktické zopakovanie počas prvých týždňov a ďalšie cielené bloky podľa problémov, ktoré sa objavia doma. Informácie možno rozdeliť na:

- čo očakávať počas prvých sedení,
- ako sa správať medzi dialýzami,
- ako chrániť cievny prístup,
- ktoré príznaky treba oznámiť dialyzačnému tímu,
- koho kontaktovať pri akútnom probléme.

Konkrétny tekutinový, diétny a liekový režim musí zostať individualizovaný. Univerzálny zoznam zákazov nenahrádza posúdenie reziduálnej diurézy, interdialyzačných prírastkov, krvného tlaku, výživového stavu ani laboratórnych výsledkov.

2. Partnera starostlivosti zaradiť medzi adresátov edukácie

Ak s tým pacient súhlasí, partner starostlivosti má dostať informácie potrebné pre úlohy, ktoré skutočne vykonáva. Treba pritom rešpektovať pacientovu autonómiu, súkromie a rozhodovaciu spôsobilosť. Užitočné je výslovne sa dohodnúť:

- kto organizuje dopravu a termíny,
- kto sleduje lieky a zmeny predpisov,
- kto a kedy komunikuje s pracoviskom,
- ktoré varovné príznaky vyžadujú okamžitý kontakt,
- čo pacient zvláda samostatne a kde pomoc nechce.

3. Overovať porozumenie metódou teach-back

Po vysvetlení možno pacienta alebo partnera požiadať, aby vlastnými slovami opísal, čo urobí v konkrétnej situácii. Nejde o skúšanie pacienta, ale o kontrolu zrozumiteľnosti komunikácie. Menšie intervenčné štúdie u hemodialyzovaných pacientov naznačujú, že edukácia s metódou *teach-back* môže zlepšiť vedomosti, sebaúčinnosť a sebariadenie. Prenositeľnosť týchto výsledkov na všetkých starších pacientov a všetky dialyzačné pracoviská však nemožno považovať za samozrejmú.

4. Pýtať sa aj na kapacitu partnera starostlivosti

Partner starostlivosti môže mať vlastné ochorenia, zamestnanie, finančné obmedzenia alebo ďalšie opatrovateľské povinnosti. Dialyzačný tím by sa nemal pýtať iba „kto vám pomáha“, ale aj „čo táto pomoc stojí človeka, ktorý ju poskytuje“. Varovnými znakmi sú vyčerpanie, strata spánku, zanedbávanie vlastnej liečby, konflikty a pocit, že pomoc nemá hranice.

5. Vytvoriť jednoduchý spoločný plán

Krátky plán použiteľný doma môže obsahovať rozpis dialýz a dopravy, aktuálny zoznam liekov, kontakty, pokyny k cievnemu prístupu a dohodnutý postup pri varovných príznakoch. Má byť čitateľný, pravidelne aktualizovaný a dostupný pacientovi aj partnerovi starostlivosti.

Čo štúdia nedokazuje

- Neurčuje, ktorá edukačná intervencia je najúčinnejšia.
- Neporovnáva výsledky pacientov s partnerom starostlivosti a bez neho.
- Nedokazuje zníženie mortality, hospitalizácií ani komplikácií dialýzy.
- Neumožňuje zovšeobecniť skúsenosti jedného amerického zdravotníckeho systému na všetky kultúrne a sociálne podmienky.
- Nenahrádza individuálne rozhodovanie o vhodnosti dialýzy, konzervatívnej liečby ani inej modality náhrady funkcie obličiek.

Praktický minikontrolný zoznam pre tím

1. Vieme, koho pacient považuje za svojho hlavného partnera starostlivosti?
2. Máme pacientov súhlas zapojiť túto osobu do komunikácie?
3. Rozumejú obaja svojím úlohám a hraniciam?
4. Bola edukácia zopakovaná po začatí dialýzy?
5. Overili sme porozumenie, nie iba odovzdanie materiálu?
6. Má dvojica písomný plán pre bežný deň aj akútny problém?
7. Pýtali sme sa na záťaž, zdravie a potreby partnera starostlivosti?

Záver

Hlavným odkazom štúdie nie je jednoduché „pacienta viac poučte“. Starší pacient a jeho partner starostlivosti potrebujú postupnú prípravu na konkrétny život s hemodialýzou: rozumieť liečbe, rozdeliť si úlohy, plánovať, vedieť požiadať o pomoc a chrániť zdravie oboch členov dvojice.

Kvalita dialyzačnej starostlivosti sa preto neukazuje iba v Kt/V, ultrafiltrácii alebo laboratórnych hodnotách. Ukazuje sa aj v tom, či pacient a jeho blízky človek dokážu bezpečne a udržateľne zvládnuť dni medzi jednotlivými výkonmi.

Zdroje

1. **Nicole DePasquale, Casey J. Powell, Francisca A. Hammond, Jessica M. Alvarez, Rasheeda K. Hall, C. Barrett Bowling.** *Advice for Living With Hemodialysis: A Qualitative Study of Older Patients and Their Care Partners.* American Journal of Kidney Diseases. 2026;88(4):508–520.e1. doi: 10.1053/j.ajkd.2026.04.004. PubMed; DOI.

2. **Yan Liu, Xi Luo, Xue Ru, Caijin Wen, Ning Ding, Jing Zhang.** *Impact of a multimodal health education combined with teach-back method on self-management in hemodialysis patients: A randomized controlled trial.* Medicine. 2024;103(52):e39971. doi: 10.1097/MD.0000000000039971. PubMed.
3. **Rasheeda K. Hall, Jeanette Rutledge, Cathleen Colón-Emeric, Laura J. Fish.** *Unmet Needs of Older Adults Receiving In-Center Hemodialysis: A Qualitative Needs Assessment.* Kidney Medicine. 2020;2(5):543–551.e1. doi: 10.1016/j.xkme.2020.04.011. PubMed.

Poznámka k dôkazom: *Primárna práca je kvalitatívna štúdia zo systému Duke Health, nie randomizovaná skúška. Počet účastníkov, vekové kritérium, trvanie hemodialýzy, analytický postup, všetkých sedem tematických výsledkov, autorstvo, strany, DOI, PII a PMID boli overené cez PubMed E-utilities a otvorené univerzitné metadáta. Praktický minikontrolný zoznam a návrh implementácie sú odborným prekladom výsledkov do ambulantnej a dialyzačnej praxe, nie doslovným odporúčaním autorov ani preukázaným účinkom konkrétneho modelu starostlivosti.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=rady-hemodialyza-starsi-pacienti-partneri-starostlivosti · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.